外科学 外科总论

核心精讲·麻醉

（性感认识：简化思路）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

围术期:维持5.6~11.2轻度升高状态

一、麻醉前准备

①血糖＜8.3、尿糖可+、**尿酮须-**

②麻醉前用药：消除不良反射尤其迷走神经反射，镇痛镇静

地西泮	镇静
M-R 阻断剂 中枢M-R阻断剂	抑制腺体分泌减少误吸（小儿腺体分泌多→阿托品加大用量） 东莨菪碱还能镇静。**青光眼不用阿托品**　激动瞳孔括约肌M-R,瞳孔缩小　阻断瞳孔括约肌M-R,瞳孔扩大(前房角减小)
阿片类	镇痛镇静（小儿耐受性差→吗啡减少用量） 过量导致呼吸抑制→用纳洛酮解救（纳洛酮不是麻醉前用药）属于解毒药

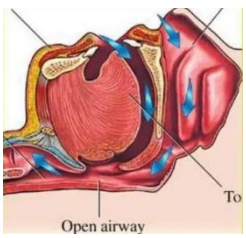
哪里痛

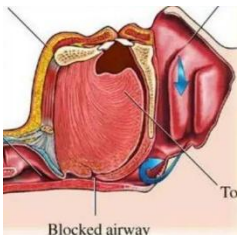
二、全身麻醉

①**舌后坠**：呼吸道梗阻最常见原因

②气管插管：导管尖至门齿距离女性 20-22、男性 22-24cm

20-22-24





（一）吸入麻醉药

①吸入麻醉药的血/气分配系数（药物在血液中的溶解度）越小→药物在中枢神经系统内的浓度越容易控制

②如果抑制了呼吸中枢→CO_2 蓄积：早期表现为呼吸加深加快、血压升高、心率加快、肌紧张增加、面色潮红甚至紫绀　缺氧

酸中毒使机体处于应激状态　刺激外周中枢化学感受器　升压反射　cap扩张

③常用药（气）：

氧化亚氮	禁用于肠梗阻（笑气笑破肚子）
地氟烷/醚	适合心脏手术（心地善良）
七氟烷/醚	呛咳屏气发生率低，可降血压（七里香对呼吸道影响小，闻着花香心情舒畅了血压也降低了）

（二）静脉麻醉药

依托咪酯	适合心脏手术（衣脱心动）
异丙酚/丙泊酚	对心血管和呼吸有明显抑制作用（异-抑制）
氯胺酮	小儿基础麻醉常用，镇痛强，可兴奋交感神经（适合休克、哮喘）激动β2受体 可致幻觉噩梦、升高颅压/眼压/血压（酮-儿童、儿童容易做噩梦、被绿了三压都高了）
咪达唑仑/咪唑安定	属于苯二氮卓类药，术前镇静
右旋美托咪定	属于中枢选择性 α_2-R 激动剂，术中镇静（美中不足）

降压药可乐定(α2-R激动剂)激动α2-R,导致副作用嗜睡